

성명 윤정혜

바코드



검진일자 2025.10.17

단체명 *****

부서명 *****

주소 서울 광진구 광장로1다길 24 신축주택

검진센터 KMI강남 검진센터

품격과 가치의 차원이 다른 건강검진 서비스

건강검진결과서

Medical Examination Report



윤정혜 여자 건강검진 결과표

검사분류	검사항목	사후관리구분
기초검사	신체계측	A 정상
	혈압	A 정상
	청력	A 정상
	당뇨	T 치료상담
	대사증후군	C(12) 경과관찰
순환기	심전도검사(일반)	A 정상
	경동맥초음파	A 정상
	지질 및 심혈관 혈액	E 상담/확인필요
갑상선	갑상선 초음파	A 정상
	갑상선 관련 혈액	A 정상
호흡기	흉부 X-ray	A 정상
위장	위장검사	C(12) 경과관찰
간, 담도, 췌장	간, 담도, 췌장 영상	C(12) 경과관찰
	간,담도,췌장 혈액 & 간염 바이러스	A 정상
신장요로	신장 기능 혈액검사	A 정상
	소변 검사	A 정상
혈액	혈액학 & 철대사	E 상담/확인필요
종양표지자	종양표지자	A 정상
통풍	통풍 및 염증	A 정상
근골격	골대사 및 부갑상선	C(1) 경과관찰
여성의학	유방 X-ray	A 정상
	유방초음파	A 정상
	성매개감염병(여)	A 정상



사후관리구분

사후관리구분은 수검자께서 한눈에 보기
편하도록 만든 것입니다. 더욱 자세한 내용은
다음 장의 종합소견과 홈페이지에서
참고하십시오.

- 👍

A: 정상
검진결과 특이 소견이 없습니다.
- ✓

B: 임상적 의의없음
정상범위를 벗어나, 임상적 의미가
없어 특별한 치료가 필요하지
않습니다.
- 🕒

C: 경과관찰 (개월수)
검사결과 추적관찰이 필요합니다.
()개월 후에 예약 후 추적 검사를 통해
경과를 관찰하십시오.
- ⚠️

E: 상담/확인검사 필요
검진 결과, 치료 여부를 결정하기 위한
전문의 상담 및 정밀 검사가
필요합니다.
- 🏥

T: 치료상담
검사상 치료 혹은 상급병원 전원이
필요합니다. 상담에 따라 진료
받으시기 바랍니다.
- ⊗

F: 불완전 검사
검진결과 정확한 진단을 내리기
어려웁니다. 안내에 따라 재검사가
필요할 수 있습니다.
- 💡

U: 예측 검진 항목 및 기타
확진이 아닌 의학적, 임상적 연구
결과를 기반으로 한 예측 검진
항목입니다. 결과에 따라 개인의
잠재적 건강상태를 예측할 수 있으며
확진을 위하여 추가적인 검사가 필요할
수 있습니다. 그 외 기타사항을
안내드립니다.



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.



T:치료 상담이 필요합니다.

당뇨

당뇨병 환자에서 이상적인 혈당 목표치는 80~130mg/dl로 현재 해당 범위내에 듭니다. 당뇨병으로 인한 합병증 예방을 위해 꾸준히 식이조절과 운동을 하시고 주기적으로 전문의의 진료를 통해 혈당 관리를 하시기 바랍니다.



E:상담/확인검사 필요합니다.

지질 및 심혈관 혈액

LDL-콜레스테롤은 심혈관 질환의 주요 위험인자입니다. 검사상 LDL-콜레스테롤이 참고범위내에 있으나 당뇨병의 경우 특히 더 낮게 조절해야 하므로 전문의와 상담하십시오. 그외 고혈압, 흡연, 심혈관질환의 가족력 등도 위험을 높입니다.

혈액학 & 철대사

혈소판이 높습니다. 이는 출혈성 또는 용혈성 질환, 심한 빈혈, 혈소판 증가와 관련된 혈액 질환등에서 증가합니다. 전문의 상담하여 추적 검사 또는 필요시 추가 정밀 검사로 확인하십시오.



C:경과 관찰이 필요합니다.

대사증후군

귀하는 위의 항목 중 기준치가 넘는 항목이 두 가지 이하(고중성지방혈증,혈당 장애)이므로 대사증후군으로 진단되지는 않습니다만 건강한 생활을 위하여 대사증후군에 대한 내용을 참고하시고 1년 뒤 추적관찰 하시기 바랍니다. ※ 혈압 및 HDL, 중성지방, 공복혈당의 경우 수치가 정상이어도 해당 약물 복용 시 기준치가 넘는 항목으로 분류되오니 참고 바랍니다.

지질 및 심혈관 혈액

중성지방이 다소 높아 경계영역에 있습니다. 고지혈증은 고혈압, 당뇨병, 비만 등과 더불어 심혈관 및 뇌혈관 질환의 위험을 높입니다. 적정 체중유지와 규칙적 운동 및 술, 단음식 및 기름진 음식의 섭취를 줄이시고 2~3개월 후 추적검사 하십시오.

위장검사

내시경 검사상 미란성 위염 소견입니다. 미란이란 위점막이 염증으로 부어오르거나 아주 미세하게 혈어있는 것으로 스트레스나 음주, 소염진통제 복용 등에 의해서도 발생합니다. 증상이 있으면 약물치료 받으시기 바랍니다. 경과 관찰위해 1년후 내시경 검사 받으시기 바랍니다.

간,담도,췌장 영상

복부초음파에서 지방간 경증 추정입니다. 간에 지방이 과다 축적된 상태로 비만, 음주, 고지혈증, 당뇨병, 약물 등이 원인으로 알려져있습니다. 향후 동맥경화, 간경화 등의 위험요인이 되므로 본인에게 해당되는 사항이 있으면 교정하시고 정기적인 검사를 받으십시오.

골다사 및 부갑상선

무기인이 높습니다. 이는 신장질환, 부갑상선 질환 등에서 볼 수 있으나 검체용혈에 의해서도 영향을 받습니다. 전문의와 상담하시고 재검하여 확인하십시오.



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.

A:정상입니다.

신체계측 허리둘레 정상

혈압 혈압 검사 결과 정상 범위(90/60mmHg~119/79mmHg) 입니다. 혈압은 측정 시마다 변하는 것이 정상이며 고혈압 진단을 위해서는 반드시 안정 상태에서 혈압을 측정해야 합니다. 규칙적인 운동 및 저염식이 등 생활습관 관리하시고 주기적으로 편안한 상태에서 혈압을 측정하시기 바랍니다.

청력 청력 정상

심전도검사(일반) 정상

경동맥초음파 특이소견없음

갑상선 초음파 특이소견없음

갑상선 관련 혈액 정상

흉부 X-ray 흉부 X-선 검사에서 특이소견이 관찰되지 않습니다. 향후 기간에 관계없이 이상 자각증상(흉통, 호흡곤란, 기침, 가래, 열 등)이 있을 경우 전문의 상담 및 추가검사를 받으십시오.

간,담도,췌장 혈액 & 간염 바이러스 B형간염 바이러스 검사상 항체 (anti-HBs)가 음성입니다. B형 간염에 대한 예방 접종을 권유합니다.

신장 기능 혈액검사 정상

소변검사 정상

통풍 및 염증 정상

유방 X-ray 유방 X-선 검사상 치밀유선조직 소견입니다. 유방조직이 치밀한 상태로 실제 병소가 가려질 수 있습니다. 유방속의 숨어있는 보이지 않는 병변발견을 위해서는 초음파 검사를 하시기 바랍니다.



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.

유방초음파

유방초음파에서 특이소견이 관찰되지 않습니다. 그러나 만저지는 멍울이 있거나 임상증상(유두분비물, 유두습진, 피부비후, 양측 유방 크기의 비대칭적 변화, 유두의 위치 변화, 통증 등)이 있을 경우 기간에 관계없이 유방외과 전문의 상담 및 추가검사를 받으십시오.

성매개감염병(여)

정상

종양표지자

CA125II 검사상 이상이 없습니다. CA125는 난소암, 자궁내막암, 체장암 등에 대한 종양표지자이나 진단을 위한 보조적 방법으로, 확진 또는 선별 검사는 아닙니다. 따라서 상기질환 의심시 비특정상범위라해도 반드시 전문의 상담을 요합니다.

AFP 검사상 이상이 없습니다. AFP는 간암, 만성간염 등에 대한 종양표지자이나 이는 복부초음파검사 등 다른 진단적 방법에 대한 보조적 검사로서 확진 또는 선별검사는 아닙니다. 그러므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

CEA 검사상 정상범위내에 있습니다. CEA는 대장암 및 폐암에 대한 종양 표지자 검사이나 진단에 보조적 방법으로 선별검사나 확진검사는 아니므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

판정의 : 정수영 2025.10.17

항목별 세부진단결과



홈페이지에서 보다 상세한
건강검진 결과를 확인하세요



기초검사

신체계측

검사항목	중간결과(24.09.28)	현재결과
신장 (cm)	160.5	160.5
체중 (kg)	51.0	47.8
체질량지수(BMI) (kg/m ²)	19.8	18.6
허리둘레 (cm)	74	69.0

신체계측

신체계측(신장, 체중)을 통해 비만도를 측정할 수 있습니다. 비만도를 측정하는 방법 중 하나인 BMI는 체중을 신장으로 나눈 수치입니다. 체지방량과 관련이 높고 상대적으로 키의 영향을 적게 반영해 비만도 측정에 가장 많이 사용됩니다.

$BMI = \text{체중(kg)} \div \text{신장(m)}^2$

저 체 중	18.5 미만
정 상	18.6 이상 ~ 23 미만
과 체 중	23 이상 ~ 25 미만
비 만	25 이상 ~ 30 미만
고 도 비 만	30 이상

체성분

체성분 검사란 몸에 있는 수분, 단백질, 지방 등의 비율을 확인하는 검사입니다. 우리 몸에 약한 전류를 흘린 후 양쪽 손과 발에서 전류의 흐름을 측정함으로써 몸의 구성성분을 간접적으로 측정합니다.

소견

허리둘레 정상

 기초검사

혈압검사

검사명	종전결과(24.09.28)	현재결과
수축기혈압	110	116
이완기혈압	69	67
※혈압	정상	정상
맥박수	94	98

혈압
혈압검사는 안정 상태에서 수축기와 이완기의 혈압을 측정합니다. 혈압은 운동, 스트레스, 안정 상태 등에 따라 변하므로 한 번의 측정으로 고혈압을 진단할 수는 없습니다. 혈압이 높게 측정된 경우 가정에서 주기적으로 혈압을 측정해서 확인하는 것이 필요하며 가정에서도 계속 높을 경우 혈압 확인을 위해 병원진료 및 24시간 활동혈압측정 등의 검사가 필요할 수 있습니다.

 소견

혈압 검사 결과 정상 범위(90/60mmHg~119/79mmHg) 입니다. 혈압은 측정 때마다 변하는 것이 정상이며 고혈압 진단을 위해서는 반드시 안정 상태에서 혈압을 측정해야 합니다. 규칙적인 운동 및 저염식이 등 생활습관 관리하시고 주기적으로 편안한 상태에서 혈압을 측정하시기 바랍니다.

안과 검사

	종전결과()	현재결과
시력(좌)		0.9
시력(우)		0.8
 소견		

안압검사

안압검사는 안압 상승을 동반하는 녹내장을 조기에 선별할 수 있는 검사입니다. 하지만 안압 상승만으로 녹내장을 진단할 수 없으며 정상 안압 녹내장도 흔하기 때문에 안저 촬영 결과물 같이 참고해야 하며 증상이 있는 경우 반드시 안과 진료가 필요합니다.

안저 검사

안저는 눈안쪽에 있는 부위로 망막과 혈관, 맥락막, 뇌로 이어지는 시신경의 출입구 등이 존재합니다. 안저 촬영을 통해 실명의 주된 원인인 망막질환, 녹내장, 백내장을 초기에 발견할 수 있습니다.

안저 검사 대상질환

망막질환, 녹내장, 백내장



기초검사

청력 검사

중진결과(24.09.28)			현재결과
청력검사	청력 정상	청력 정상	
청력 500Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)	
청력 1000Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)	
청력 2000Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)	
청력 4000Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)	

청력검사

청력은 각 주파수마다 25dB 이상인 강도의 소리만 들을 수 있는 경우 이상이 있다고 판정하며, 주파수에 따라 다르지만 40dB 이상인 높은 강도의 소리만 들을 수 있는 경우에는 일상 생활에 지장이 있을 수 있습니다.



소견

청력 정상

당뇨 검사

	중진결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
공복혈당	130	▲ 110			

당뇨 검사 임상 참고치

공복혈당	70 ~ 99mg/dl
------	--------------



소견

당뇨병 환자에서 이상적인 혈당 목표치는 80~130mg/dl로 현재 해당 범위내에 듭니다. 당뇨병으로 인한 합병증 예방을 위해 꾸준히 식이조절과 운동을 하시고 주기적으로 전문의의 진료를 통해 혈당 관리를 하시기바랍니다.

당뇨검사

당뇨병의 진단기준은 공복 혈당 126mg/dl 이상이거나 당화혈색소가 6.5% 이상인 경우입니다. 공복혈당이 100~125mg/dl 또는 당화혈색소 5.7~6.4%인 경우에는 당뇨병 전 단계(공복 혈당 장애)로 진단하며, 향후 당뇨병으로 진행될 가능성이 높습니다. 따라서 당뇨병 전 단계(공복 혈당 장애)에 해당 하는 경우에는 식이조절, 운동 및 체중조절 등의 건강한 생활 습관을 유지하기 위한 노력을 기울여야 하며 정기적인 혈당검사를 받아야 합니다.



기초검사

대사증후군

	중진결과(24.09.28)	한재결과
수축기혈압	110	116
이완기혈압	69	67
공복혈당	130	110
중성지방(Triglyceride)	102	169
HDL-Cholesterol	59	58
허리둘레	74	69.0



소견

귀하는 위의 항목 중 기준치가 넘는 항목이 두 가지 이하(고중성지방혈증, 혈당 장애)이므로 대사증후군으로 진단되지는 않습니다만 건강한 생활을 위하여 대사증후군에 대한 내용을 참고하시고 1년 뒤 추적관찰 하시기 바랍니다. ※ 혈압 및 HDL, 중성지방, 공복혈당의 경우 수치가 정상이어도 해당 약을 복용 시 기준치가 넘는 항목으로 분류되오니 참고 바랍니다.

대사증후군

대사증후군이란, 심뇌혈관질환 및 당뇨병의 위험을 높이는 체지방 증가, 혈압 상승, 혈당 상승, 혈중 지질 이상등의 이상 상태들의 집합을 말합니다. 대사증후군이 있는 경우에는 심혈관 질환의 위험을 두 배 이상 높이며, 당뇨병의 발병을 10배 이상 증가시킵니다. 이러한 대사증후군은 단일한 질병이 아니라 유전적 소인과 환경적 인자가 더해져 발생하는 포괄적 질병입니다.

대사증후군 검사

일반적으로 아래의 기준 중 세 가지 이상 해당이 되면 대사증후군으로 정의합니다.

- ① 복부비만: 허리둘레 남자 90cm, 여자 85cm 이상
- ② 고중성지방혈증 : 중성지방 150mg/dL 이상 또는 고중성지질혈증을 치료하기 위해 약물 투여 중인 상태
- ③ 낮은 HDL 콜레스테롤 혈증: 남자 40mg/dL, 여자 50mg/dL 미만 또는 고지질혈증약을 복용하는 경우
- ④ 높은 혈압: 130/85mmHg 이상 또는 고혈압약을 복용하는 경우
- ⑤ 혈당 장애: 공복 혈당 100 mg/dL 이상 또는 당뇨병 과거력, 또는 약물 복용



순환기

심전도검사(일반)

종전결과(23.11.04)		현재결과
심전도검사(일반)	정상	정상
소견		
정상		

심전도검사(일반)

심전도는 심장의 전기 에너지를 체표면에 부착한 전극을 통해 그래프를 기록해 나타내주는 검사입니다. 심장 질환에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있으며 특정 질환을 의심할 수 있는 소견이 보이는 경우 순환기내과 진료가 필요합니다.

경동맥 초음파 검사

종전결과(24.09.28)		현재결과
경동맥초음파	특이소견없음	특이소견없음
소견		
특이소견없음		

경동맥 초음파 검사

초음파를 이용해 목 부위 주요 동맥의 상태를 확인하는 검사로, 경동맥의 비대 여부, 플라크 존재 여부, 협착 상태 등을 평가할 수 있습니다. 이 검사를 통해 동맥경화 등으로 인한 경동맥 협착 여부를 직접 확인할 수 있으며, 간접적으로 뇌혈관 건강 상태도 파악할 수 있습니다.



순환기

지질 및 심혈관 혈액검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
총콜레스테롤(T-Cholesterol)	165	194			
중성지방(Triglyceride)	102	▲ 169			
HDL-Cholesterol	59	58			
LDL-Cholesterol	86	102			

지질 및 심혈관 임상 참고치

총콜레스테롤(T-Cholesterol)	120 ~ 199mg/dl
중성지방(Triglyceride)	50 ~ 149mg/dl
HDL-Cholesterol	40 ~ 60mg/dl
LDL-Cholesterol	50 ~ 129mg/dl

2 소견

중성지방이 다소 높아 경계영역에 있습니다. 고지혈증은 고혈압, 당뇨병, 비만 등과 더불어 심혈관 및 뇌혈관 질환의 위험을 높입니다. 적정 체중유지와 규칙적 운동 및 술, 단 음식 및 기름진 음식의 섭취를 줄이시고 2~3개월 후 추적검사 하십시오.

LDL-콜레스테롤은 심혈관 질환의 주요 위험인자입니다. 검사상 LDL-콜레스테롤이 참고범위내에 있으나 당뇨병의 경우 특히 더 낮게 조절해야 하므로 전문의와 상담하십시오. 그외 고혈압, 흡연, 심혈관질환의 가족력 등도 위험을 높입니다.

지질 및 심혈관 혈액 검사

지질 검사 중 HDL-콜레스테롤은 동맥경화 예방효과가 있으므로 기준치 보다 높을수록 좋으며, LDL-콜레스테롤, 총 콜레스테롤, 중성지방은 높을수록 동맥경화를 악화 시키므로 기준치 이하로 유지되도록 노력해야 합니다.

지질 혈액 검사 대상질환

심근경색증, 동맥경화증, 고지혈증



갑상선

갑상선 초음파 검사

종전결과(24.09.28)

현재결과

갑상선 초음파

특이소견없음

특이소견없음

갑상선 초음파

갑상선 초음파 검사는 초음파를 이용하여 갑상선의 내부 구조와 주위 조직을 확인하고 갑상선 내 혹(결절)의 모양, 크기, 상태를 확인합니다.



소견

특이소견없음

갑상선 기능 혈액검사

종전결과(24.09.28)

현재결과

낮음 정상 높음

※ TSH

2.00

3.35

↓

[※] 표시 항목은 검사방법 변경으로 인해 기준치가 종전결과와 상이함.



소견

정상

갑상선 기능 임상 참고치

TSH

0.35 ~ 5.5uIU/mL

갑상선 기능 혈액 검사

Free T4(갑상선호르몬) 감소 시에는 갑상선 기능 저하증을, 증가 시에는 갑상선 기능 항진증을 의미합니다.
TSH(갑상선자극호르몬)는 뇌하수체에서 분비되어 갑상선의 기능을 조절합니다.
갑상선의 기능이 저하될 때 증가하고, 항진될 때 감소합니다.

갑상선 기능 혈액 검사 대상질환

갑상선기능 저하증, 갑상선 기능 항진증

 호흡기

흉부 X-ray

종전결과(24.09.28)		현재결과
흉부직접촬영	정상	정상

흉부 X-ray 검사
X-ray를 이용하여 폐 부위와 심장, 종격동, 횡격막 및 새골, 늑골, 흉추 등의 이상을 가장 간단하게 확인할 수 있는 검사입니다.

소견

흉부 X-선 검사에서 특이소견이 관찰되지 않습니다. 향후 기간에 관계없이 이상 자각증상(흉통, 호흡곤란, 기침, 가래, 열 등)이 있을 경우 전문의 상담 및 추가검사를 받으십시오.



위장

위장검사

종전결과(23.11.25)		현재결과
위 내시경	불완전 검사	미완성 위염
소견		

내시경 검사상 미란성 위염 소견입니다. 미란이란 위점막이 염증으로 부어오르거나 아주 미세하게 혈어있는 것으로 스트레스나 음주, 소염진통제 복용 등에 의해서도 발생합니다. 증상이 있으면 약물치료 받으시기 바랍니다. 경과 관찰위해 1년후 내시경 검사 받으시기 바랍니다.

위 내시경 검사

위내시경 검사는 내시경을 경구 삽입하여 식도나 위, 십이지장에 발생하는 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염 등 여러 종류의 질환을 진단하는 방법입니다. 위내시경 검사에서 구조적 질환이 없어도 복부 팽만감, 속쓰림 등의 증상은 있을 수 있으며 증상이 심할 경우 전문의의 진료가 도움이 될 수 있습니다.

위장조영 검사

위장조영술은 조영제를 경구 섭취한 뒤 위와 십이지장에 코팅된 조영제를 X-ray로 투시함으로써 각 장기의 모양 및 병변을 확인하는 검사입니다. 위내시경에 비해 불편감이 덜하고 금기 사항이 적지만 확진할 수 있는 검사가 아니기 때문에 위장조영술에서 이상 소견 발견 시 위내시경으로 다시 확인해야 합니다.



간, 담도, 췌장

간, 담도, 췌장 영상

종전결과(24.09.28)

안정결과

복부초음파

지방간 경증

지방간 경증 추정

소견

복부초음파에서 지방간 경증 추정입니다. 간에 지방이 과다 축적된 상태로
비만, 음주, 고지혈증, 당뇨병, 약물 등이 원인으로 알려져 있습니다. 향후
동맥경화, 간경화 등의 위험요인이 되므로 본인에게 해당되는 사항이 있으면
교정하시고 정기적인 검사를 받으십시오.

복부 초음파 검사

복부 초음파 검사는 초음파를 이용하여
상복부에 있는 간, 신장(콩팥), 담낭(쓸개),
췌장, 비장의 이상을 확인하는 검사로 상복부
내 여러 장기를 비교적 쉽고 빠르게 확인 할 수
있는 장점이 있으나, 복부 내 가스 유무 등에
따라 검사 진행이 어려울 수 있습니다.



간, 담도, 췌장

간, 담도, 췌장 혈액 및 간염바이러스

총진결과(24.09.28)		현재결과	낮음	정상	높음
총단백(T.Protein)	7.0	7.0			
알부민	4.3	4.3			
글로불린(Globulin)	2.7	2.7			
A/G 비율	1.6	1.6			
총빌리루빈	0.4	0.4			
직접빌리루빈	0.2	0.2			
간접빌리루빈	0.2	0.2			
AST(SGOT)	26	28			
ALT(SGPT)	17	13			
γ-GTP	11	12			
Alk.Phosphatase(ALP)	48	58			
Amylase	59	53			
HBS Ag(정량)	음성 (0.11)	음성 (0.19)			
HBS Ab(정량)(CLIA)	음성 (<3.10)	음성 (<3.10)			

소견

B형간염 바이러스 검사상 항체 (anti-HBs)가 음성입니다. B형 간염에 대한 예방 접종을 권유합니다.

검사항목	결과의미
B형간염 표면항체(HBs Ab)	양성 : B형간염 면역상태 음성 : B형간염 비면역 상태
B형간염 항원(HBs Ag)	양성 : B형간염 바이러스 보유 음성 : B형간염바이러스 미보유
A형 간염 항체(HAV Ab)	양성 : 과거 A형 간염 감염 또는 백신접종으로 인한 면역 상태 음성 : 현재 C형 간염 바이러스 보유 또는 과거 감염 상태

※ 해당 설명은 결과가 아닌 이해를 돕기 위한 참고 자료입니다.

간, 담도, 췌장 임상 참고치

총단백(T.Protein)	6.0 ~ 8.3 g/dl
알부민	3.5 ~ 5.2 g/dl
글로불린(Globulin)	1.5 ~ 3.0 g/dl
A/G 비율	1.3 ~ 2.3
총빌리루빈	0.2 ~ 1.2 mg/dl
직접빌리루빈	0.0 ~ 0.5 mg/dl
간접빌리루빈	0.2 ~ 0.7 mg/dl
AST(SGOT)	0 ~ 32 IU/L
ALT(SGPT)	0 ~ 34 IU/L
γ-GTP	6 ~ 42 IU/L
Alk.Phosphatase(ALP)	40 ~ 150 IU/L
Amylase	16 ~ 109 U/L
HBS Ag(정량)	음성 <1 1 ≤ 약양성 ≤ 49.99 양성 ≥ 50
HBS Ab(정량)(CLIA)	10 ≤ 약양성 ≤ 29.99 양성 ≥ 30 (mIU/mL)

간기능 혈액 검사

간, 담도, 췌장은 해부학적으로 매우 인접해 있을 뿐 아니라 간에서 만들어진 담즙이 담도로 내려가고 췌장에서 만나 십이지장으로 분비되기 때문에 서로 유기적인 연결 관계에 있습니다. 혈액 검사와 간염 검사를 통해 간, 담도, 췌장의 질환 여부를 파악하게 됩니다.

간기능 혈액 검사 대상 질환

간염, 간경변증, 간질한, 담도질환 등



신장요로

신장 기능 혈액검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
요소질소	13	13			
Creatinine	0.8	0.68			
BUN/Cr 비율	16.3	19.1			
사구체여과율(GFR)		98			

신장 기능 혈액검사 임상 참고치

요소질소	5 ~ 20mg/dl
Creatinine	0.50 ~ 1.40mg/dl
BUN/Cr 비율	10 ~ 20%
사구체여과율(GFR)	60 ~ 10000

소견

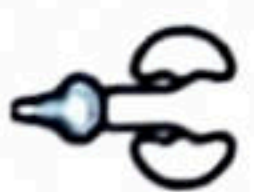
정상

신장 기능 혈액 검사

신장은 우리 몸속에서 노폐물을 제거하는 기능을 하며 요소질소와 크레아티닌은 신장의 기능과 연관된 지표입니다. 요소질소는 탈수와 같은 일상적인 상황에서도 흔하게 상승하기 때문에 반드시 크레아티닌 검사 결과와 같이 해석해야 하며, 크레아티닌이 증가한 경우에는 신장 기능에 문제가 있을 가능성이 크기 때문에 신장 내과 진료가 필요합니다.

신장 기능 혈액 검사 대상질환

신장질환, 신부전, 탈수 등



신장요로

소변검사

중진결과(24.09.28)		현재결과	낮음	정상	높음
요중백혈구(WBC)	±	-			
요중Nitrite	-	-			
요비중(Sg)	1.020	1.023			
pH (요검사)	6.0	5.0			
요단백	-	-			
당(요검사)	-	-			
요중케톤체량	-	-			
유로빌리노겐	±	±			
요빌리루빈	-	-			
요장혈	-	-			



소견

정상

소변검사 임상 참고치

요중백혈구(WBC)	- , ±
요중Nitrite	-
요비중(Sg)	1.005 ~ 1.030
pH (요검사)	5.0 ~ 8.0
요단백	-
당(요검사)	-
요중케톤체량	- , ±
유로빌리노겐	- , ±
요빌리루빈	-
요장혈	- , ±

소변 검사

소변 검사 상 단백뇨와 혈뇨는 심한운동, 약물치료, 생리 등에 의해서도 일시적으로 나타날 수 있지만 반복된 검사에도 단백뇨와 혈뇨가 지속되고 당뇨, 고혈압과 같은 신기능 장애를 유발하는 기저 질환이 있다면 신장질환이 동반되었을 가능성이 매우 높으므로 신장 내과 진료가 필요합니다. 소변에서 관찰되는 백혈구는 임상적 의미는 크지 않지만 질 분비물이 오염되거나 요로 감염 시 나타날 수 있기 때문에 관련된 증상이 있는 경우 관련 전문의 진료가 필요합니다.

소변 검사 대상질환

당뇨병, 요로감염, 신장질환, 방광암 등

혈액

혈액학 & 철대사

	종전결과(240928)	현재결과	낮음	정상	높음
혈색소량(Hb)	12.4	12.9		■	■
혈구용적치(HCT)	36.4	38.8		■	■
※ 적혈구수	400	4.29		■	■
적혈구용적(MCV)	91.0	90.4		■	■
적혈구혈색소량(MCH)	31.0	30.1		■	■
적혈구혈혈색소농도(MCHC)	34.1	33.2		■	■
RDW	12.9	12.7		■	■
백혈구수	5.13	6.20		■	■
분획호중구	56	52		■	■
림프구	32	32		■	■
단핵구	7	8		■	■
호산구	4	6		■	■
호염기구	1	▲ 2		■	■
※ 혈소판수	35.3	▲ 427		■	■
PDW	12.2	13.0		■	■
MPV	10.6	10.6		■	■
Fe	87	63		■	■

[※] 표시 항목은 단위 변경으로 인해 기준치가 종전결과와 상이함.

소견

혈소판이 높습니다. 이는 출혈성 또는 용혈성 질환, 심한 빈혈, 혈소판 증가와 관련된 혈액 질환등에서 증가합니다. 전문의 상담하여 추적 검사 또는 필요시 추가 정밀 검사로 확인하십시오.

혈액학 & 철대사 검사 임상 참고치

혈색소량(Hb)	12.0 ~ 15.8g/dL
혈구용적치(HCT)	34.5 ~ 46.8%
적혈구수	3.70 ~ 5.20x10 ⁶ /μL
적혈구용적(MCV)	80.0 ~ 98.3fL
적혈구혈색소량(MCH)	25.0 ~ 32.8pg
적혈구혈혈색소농도(MCHC)	31.0 ~ 35.0g/dl
RDW	11 ~ 15.2%
백혈구수	3.7 ~ 9.8x10 ³ /μL
분획호중구	36 ~ 70%
림프구	21 ~ 50%
단핵구	3 ~ 11%
호산구	0 ~ 9%
호염기구	0 ~ 1%
혈소판수	138 ~ 398x10 ³ /μL
PDW	9.6 ~ 16.2fL
MPV	9.0 ~ 12.5fL
Fe	50 ~ 170ug/dl

일반 혈액 검사

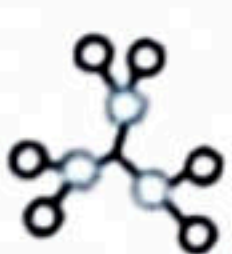
일반 혈액검사는 혈액 내 존재하는 세가지 종류의 세포, 즉 적혈구, 백혈구, 혈소판의 양 및 특성을 평가하는 검사로 전반적인 건강상태를 나타내며, 다양한 질환의 선별 검사와 추적 관찰에 이용됩니다.

일반 혈액 검사 대상질환

적혈구 증가&감소, 백혈병 등

빈혈

빈혈 검사는 빈혈의 원인을 확인하기 위한 검사입니다. 철은 적혈구 생성에 필수적인데, 생리량이 많거나 위장관 출혈 등으로 체외로 혈액이 빠져나가면 철분도 함께 손실됩니다. 이로 인해 적혈구 생성이 어려워지며 전결핍성 빈혈이 발생합니다. 이 경우 혈중 철분과 페리틴(Ferritin)이 감소하고, 총철결합능(TIBC)은 증가하는 특징이 나타납니다.



종양표지자

종양표지자 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
CEA	0.83	0.66			
AFP(E)-수치	2.62	2.78			
CA 125II (여자)	8.16	8.48			

종양표지자 검사 임상 참고치	
CEA	0 ~ 5.00 ng/ml
AFP(E)-수치	0.00 ~ 8.09 ng/ml
CA 125II (여자)	0 ~ 35.00 U/ml

2 소견

CEA 검사상 정상범위내에 있습니다. CEA는 대장암 및 폐암에 대한 종양 표지자 검사이나 진단에 보조적 방법으로 선별검사나 확진검사는 아니므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

AFP 검사상 이상이 없습니다. AFP는 간암, 만성간염 등에 대한 종양 표지자 검사이나 이는 복부초음파검사 등 다른 진단적 방법에 대한 보조적 검사로서 확진 또는 선별검사는 아닙니다. 그러므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

CA125II 검사상 이상이 없습니다. CA125는 난소암, 자궁내막암, 췌장암 등에 대한 종양표지자이나 진단을 위한 보조적 방법으로, 확진 또는 선별 검사는 아닙니다. 따라서 상기질환 의심시 비록 정상범위리해도 반드시 전문의 상담을 요합니다.

혈액 종양표지자 검사

종양표지자는 암 발생 시 혈액 내 상승하는 표지자로 암의 조기진단 및 치료 후 치료 경과 관찰에 사용됩니다. 다만 임이 아닌 일반 질환이나 정상적인 신체 변화에도 높게 나타나거나 경우가 많고 종양표지자 상승만으로 암을 진단하는 것은 불가능하기 때문에 정상치 보다 현저히 높게 나타난 경우는 관련된 암에 대한 전문의 진료가 필요합니다.

 동국 및 면역매개질환

통풍 및 염증 반응 검사

항목	결과	참고
요산(Uric Acid)	3.1	4.1

항목	결과
요산(Uric Acid)	3 - 8mg/dl

2 소견

염증 수치 검사

COPD 환자로서 만성 염증성 질환으로 인해 요산 수치가 상승하여 통풍 발작 위험이 높습니다. 요산 수치가 4.1mg/dl 이상인 경우 통풍 발작 위험이 높으며, 요산 수치가 3.1mg/dl 이하인 경우 통풍 발작 위험이 낮습니다.

요산, 류마티스 인자

요산은 요관벽에 침착되어 통풍 발작을 일으키는 원인으로 작용합니다. 요산 수치가 4.1mg/dl 이상인 경우 통풍 발작 위험이 높으며, 요산 수치가 3.1mg/dl 이하인 경우 통풍 발작 위험이 낮습니다. 류마티스 인자는 류마티스 관절염을 진단하는 데 사용됩니다. 류마티스 인자 수치가 1.0 IU/L 이상인 경우 류마티스 관절염 위험이 높으며, 류마티스 인자 수치가 1.0 IU/L 이하인 경우 류마티스 관절염 위험이 낮습니다.

요산, 류마티스 인자 다량검출

통풍, 류마티스 관절염, 백혈병 등



근골격

골대사 및 부갑상선

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음	골대사 및 부갑상선 임상 참고치
혈청인(P)	4.5	▲ 4.9				혈청인(P) 2.5 ~ 4.5mg/dl
혈중 칼슘	9.1	9.5				혈중 칼슘 8.2 ~ 9.6mg/dl



소견

무기인이 높습니다. 이는 신장질환, 부갑상선 질환 등에서 볼 수 있으나
검체용혈에 의해서도 영향을 받습니다. 전문의와 상담하시고 재검하여
확인하십시오.



여성의학

자궁경부암 검사

종전결과()	현재결과
자궁경부세포진검사 PAP	미검진

소견

자궁 경부암 검사

자궁경부암 검사(자궁경부 세포진 검사)는 질경을 삽입하여 자궁경부를 노출시킨 다음 작은 면봉을 이용해 자궁경부 표면의 세포를 채취하고 현미경으로 확인하여 자궁경부암을 진단합니다.

유방 X-ray 검사

종전결과(24.09.28)	현재결과
유방촬영(여)	경계가 보이는 결절성 음영, 우상측. / 양성 석회화, 우측 (유두하부) / 치밀유선조직

소견

유방 X-선 검사상 치밀유선조직 소견입니다. 유방조직이 치밀한 상태로 실제 병소가 가려질 수 있습니다. 유방속의 숨어있는 보이지 않는 병변발견을 위해서는 초음파 검사를 하시기 바랍니다.

유방 X-ray 검사

X-ray를 이용하여 유방 내부 조직의 양상을 확인하는 검사로, 미세석회화 관찰에 용이하며, 유방 내부 조직의 이상 여부를 진단하는 데 유용합니다. 특히 치밀 유방이거나 유방에 멍울이 만져지는 경우, 유방촬영과 유방초음파 검사를 동시에 진행하면 보다 정확한 진단을 할 수 있습니다.



여성의학

유방 초음파 검사

종전결과(24.09.28)		현재결과
(여성)유방초음파	좌측 유방 내 결절(11시 0.4cm)	특이소견없음

소견

유방초음파에서 특이소견이 관찰되지 않습니다. 그러나 만져지는 멍울이 있거나 임상증상(유두분비물, 유두습진, 피부비후, 양측 유방 크기의 비대칭적 변화, 유두의 위치 변화, 통증 등)이 있을 경우 기간에 관계없이 유방외과 전문의 상담 및 추가검사를 받으십시오.

유방 초음파 검사

초음파를 이용하여 유방의 내부 구조와 주위 조직을 확인하여 종양, 문맥, 염종 등을 확인하는 검사입니다. 유방에 멍울이 만져지지만 유방촬영에서 이상 소견이 발견되지 않거나 치밀 유방으로 인해 숨은 병변을 발견하기 어려운 경우에 유용합니다. 유방촬영 검사와 동시에 진행하면 보다 정확한 진단을 할 수 있습니다.

성매개감염병 검사

종전결과(24.09.28)		현재결과
RPR 정밀(매독)	음성	음성

성매개감염병 검사 임상 참고치

RPR 정밀(매독)	음성
------------	----

소견

정상

 기타 검사

기타 외부 검사

	종전결과(24.09.28)	현전결과
건강성적표	별도 결과지 참고	별도 결과지 참고
Cognitive(뇌건강 측정)	별도 결과지 참고	별도 결과지 참고

 소견 _____

별도 결과지 참고 - 건강성적표, Cognitive(뇌건강 측정)

일반건강검진 결과통보서

수검자 성명 윤정혜

주민등록번호 691023-2*****

검진장소 ☒ 내원 ☐ 출장

검진일 2025년 10월 17일

한미글로벌

평택 P4L 생산시설(FAB동, 북
합동) PM

윤정혜

69.10.23

0529

건강검진 종합소견

판정 - ☐ 정상 A ☒ 정상 B (경계)

☐ 일반 질환의심 ☐ 고혈압 · 당뇨병 · 이상지질혈증 질환의심

☒ 유질환자

◆ 윤정혜님은 일반건강검진 그 외 이상지질혈증, C형간염검사를 받으셨습니다.

※ 흉부촬영검사는 폐결핵 진단검사이며, 폐암 선별검사는 아닙니다.

◆ 윤정혜님은 다음 사항에 대한 관리가 필요합니다.

▷ 의심 질환 :

해당사항없음

※ □고혈압, □당뇨병, □폐결핵, □우울증, □조기정신증, □C형간염이 의심되는 분은 병·의원((상급)종합 · 치과 · 한방 · 요양 · 정신병원, 치과 · 한의원 제외)에서 검진받은 연도의 다음연도 1월 31일까지 최초 1회 본인부담 없이 진료(아래 각주 참고)가 가능하니 꼭 받으시기 바랍니다

- 고혈압 : 진찰, 혈압측정 * 당뇨병 : 진찰, 공복혈당검사
- 정신건강검사(우울증, 조기정신증), C형간염 : 별도 안내문 참조(첫 진료비 지원 대상 관련)
- 폐결핵((상급) 종합병원 포함) : 진찰, 객담 (가래) 도말검사 및 배양검사, 핵산증폭검사

▷ 유질환 :

• 당뇨병(기왕증)입니다. - 당뇨병이 잘 조절되고 있습니다. 주치의와 지속적인 경과 관찰을 통해 관리하십시오.

▷ 생활습관 관리 :

• 일주일에 2일 이상 신체 각 부위를 모두 포함하여 근력 운동을 수행하십시오.

▷ 기타 :

• 이상지질혈증 주의 단계입니다. - 저지방 및 저탄수화물 식이, 절주, 유산소 운동이 필요합니다. 6개월 이내 정기적인 추적 관찰 하시기 바랍니다.

구분	목표질환	검사항목	결과(참고치)
계측검사	비만/복부비만	키(cm) 및 몸무게(kg)	160.5cm / 47.8kg
		체질량지수(kg/m ²)	18.6 ☐ 저체중 ☒ 정상 ☐ 과체중 ☐ 비만 (18.5 미만) (18.5-24.9) (25-29.9) (30 이상)
		허리둘레(cm)	69.0 ☒ 정상 ☐ 복부비만 (남 90cm 이상, 여 85cm 이상)
		시각이상	0.9 / 0.8 ☐ 교정 ☐ 교정 ☒ 정상 ☐ 교정 ☒ 정상 ☐ 질환의심(40dB 이상)
		청각이상	정상 / 정상 ☐ 정상 ☐ 질환의심(40dB 이상)
검사사	고혈압 (수축기/이완기)	116 / 67 mmHg	☒ 정상 ☐ 고혈압 전단계 (수축기 120-139 또는 이완기 80-89) ☐ 고혈압의심(수축기 140 이상 또는 이완기 90 이상)

혈액검사	빈혈 등	혈색소(g/dL)	12.9	남 13 - 16.5 여 12 - 15.5	☒ 정상 ☐ 기타 ☐ 빈혈의심
	당뇨병	공복혈당(mg/dL)	110	100미만	☐ 정상 ☒ 유질환자 ☐ 공복혈당장애 의심 ☐ 당뇨병 의심
	이상지질혈증	총콜레스테롤(mg/dL)	194	200미만	☐ 정상
		고밀도콜레스테롤(mg/dL)	58	60이상	☐ 고콜레스테롤혈증 의심
		중성지방(mg/dL)	169	150미만	☒ 고중성지방혈증 의심
		자밀도콜레스테롤(mg/dL)	102	130미만	☒ 낮은 고밀도 콜레스테롤 의심
		혈청 크로마닌(mg/dL)	0.68	1.5이하	☒ 정상
		신장질환 신사구체여과율(e-GFR) (mL/min/1.73m ²)	98	60이상	☐ 신장기능 이상 의심
	간장질환	에이에스티(AST) (U/L)	28	40이하	☒ 정상
		에이엘티(ALT) (U/L)	13	35이하	☐ 간기능 이상 의심
		감마지티피(γGTP)(U/L)	12	남 63이하 여 35이하	

요검사	요단백	☒ 정상 ☐ 경계 ☐ 단백뇨 의심
-----	-----	--

영상검사	흉부촬영	☒ 정상 ☐ 비활동성 폐결핵 ☐ 질환의심 : ☐ 기타 :
------	------	--

진찰 (문진)	과거병력	유 ☐ 금연 필요 ☐ 절주 필요 ☐ 약물치료 유 ☐ 신체활동 필요 ☒ 근력운동 필요
	생활습관	☐ 금연 필요 ☐ 절주 필요 ☐ 신체활동 필요 ☒ 근력운동 필요 * 담담 의사와 상담하십시오.

실시대상자 여부		결과			
B형 간염	☐ 해당 ☒ 비해당	표면항원	☐ 일반 ☐ 정밀	()	
		표면항체	☐ 일반 ☐ 정밀	()	
		☐ 항체있음 ☐ 항체없음	☐ B형 간염 보유자 의심	☐ 판정보류	
		☐ 일반 ☒ 정밀	(음성(0.04) 기준치 : 0.0~0.99)		
		☐ 항체 있음 (C형간염 의심, 확진검사 필요)	☒ 항체 없음		
C형 간염	☒ 해당 ☐ 비해당	☐ 우울증상이 없음(0~4점)	☐ 가벼운 우울증상(5~9점)		
우울증	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 중간 정도 우울증 의심(10~19점)	☐ 심한 우울증 의심(20~27점)		
조기정신증	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 증상없음(영역별 0~5점)	☐ 전문의 진단 필요(빈도 또는 고통 6점 이상)		
인지기능장애	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 특이소견 없음(0~5점)	☐ 인지기능 저하 의심(6점 이상)		
폴립도검사	☐ 해당 ☒ 비해당	측정부위		T-점수	
		고관절 ☐	☐ 정상 ☐ 골감소증 ☐ 골다공증		
		요추 ☐			
		기타 ☐			
노인신체기능검사	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 정상	☐ 신체기능저하		
노인기능평가 (문진)	☐ 해당 ☒ 비해당	낙상		☐ 정상	☐ 낙상 고위험자
		일상생활 수행능력		☐ 정상	☐ 일상생활 도움 필요
		예방접종		☐ 인플루엔자 접종 필요	☐ 폐렴구균 접종 필요
		예방접종		☐ 접종 필요 없음	☐ 접종 필요 없음
		배뇨장애		☐ 정상	☐ 배뇨장애 의심

심뇌혈관질환 위험평가

*심뇌혈관질환은 뇌졸중, 심근경색을 포괄하는 질환을 뜻합니다.
검진일자 2025-10-17

성명 윤정혜

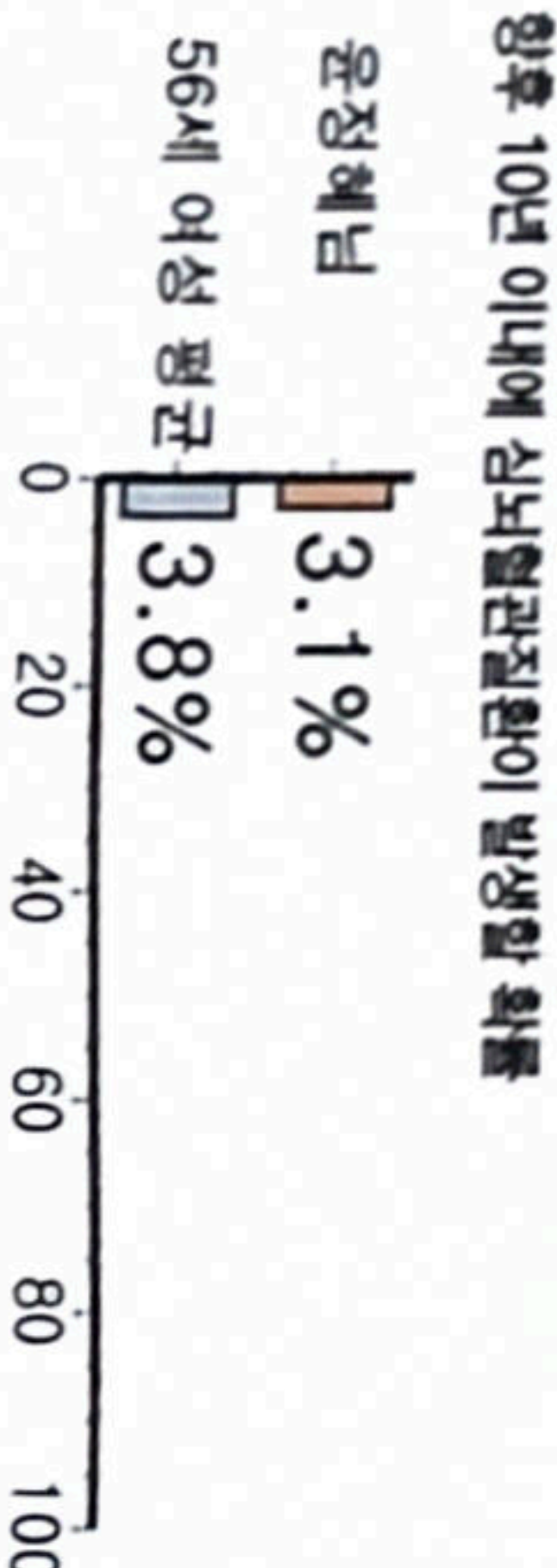
성별 여성

연령 56세

심뇌혈관질환 위험도

나의 심뇌혈관질환 발생 위험
((연령) (성별) 평균 대비)

0.81 배



심뇌혈관 나이

54세

건강관련요인 알아보기

건강관련요인	현재상태	→	목표상태	건강신호등
 체중 허리둘레	47.8kg 69.0cm		59.0kg 85.0cm 미만	
 신체활동	주 4회		주 5회 이상	
 혈압	116/67		120/80 mmHg 미만	
 담배사용	비흡연		비흡연	
 음주	비음주		비음주	
 공복혈당	110		100 mg/dL 미만	
 총 콜레스테롤 LDL 콜레스테롤	194 102		200 mg/dL 미만 100 mg/dL 미만	

위 결과는 윤정혜 님의 문진표와 검사결과를 토대로 현재상태와 목표치를 제시한 것입니다. 건강 신호등에서 '주의' 또는 '위험'에 해당하는 요인에 대해서는 적극적인 개선 노력이 필요합니다. 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 약을 드시고 계신 경우에는 혈압, 공복혈당, 콜레스테롤이 목표치로 조절되고 있어도 '주의'로 표시되며, 현재와 같이 지속적으로 관리하시길 바랍니다.

※ 위 목표 상태는 일반적인 권고인에 따른 것으로, 개인의 건강 수준에 따라 달라질 수 있으므로 의사와 상담하십시오.

건강관련요인을 개선하면

향후 10년 이내에 심뇌혈관질환이 발생할 확률이 현재 상태 대비

심뇌혈관 나이

10%감소

(3.1%

→

2.8%

)

54세

→

53세

귀하의 건강검진 결과를 위와 같이 통보합니다.

2025.10.30

판정일 : 2025.10.22

검진 의사 : 면허(자격)/번호 : 29306

성명 : 나석주

재단법인한국의학연구소강남의원(요양기관번호 : 11366338)

위암 검진 결과통보서

성명	윤정혜	주민등록번호	691023-2*****
----	-----	--------	---------------

구분	검사항목	결과	판정
위내시경검사 2025/10/17	소견	-위염(위전정부, 대만)	이상소견없음 또는 위염
	조직진단		

권고사항

내시경 검사상 미란성 위염 소견입니다. 미란이란 위점막이 염증으로 부어오르거나 아주 미세하게 혈어있는 것으로 스테로이드나 응축, 소염진통제 복용 등에 의해서도 발생합니다. 증상이 있으면 약물치료 받으시기 바랍니다. 경과 관찰위해 1년후 내시경 검사 받으시기 바랍니다.

내시경 검사상 미란성 위염 소견입니다. 미란이란 위점막이 염증으로 부어오르거나 아주 미세하게 혈어있는 것으로 스트레스나 음주, 소염진통제 복용 등에 의해서도 발생합니다. 증상이 있으면 약물치료 받으시기 바랍니다. 경과 관찰위해 1년 후 내시경 검사 받으시기 바랍니다.				
위 암		판 정 의 사	면허(자격)번호	114063
			의 사 명	정부윤 정복웅
판 정 일	2025년 10월 17일			

위암 검진 결과통보서

※(건강보험가입자) 건강검진 결과통보서상 상급종합병원에서의 요양급여가 필요하다는 의사 소견이 기재된 경우, 요양급여의뢰서(진료의뢰서)로 갈음되며 본 통보서를 활용하여 상급종합병원에서 진료를 받으실 수 있습니다.

※(의료급여수급권자) 건강검진 결과 이상소견이 발견되어 진료담당의사가 검진결과서에 추가 진료가 필요하다는 의사소견을 기재한 경우 동 검진결과서를 의료급여의뢰서로 갈음하여 검진을 실시한 의료급여기관에서 진료를 받으실 수 있습니다. 그 이외의 의료급여가 필요한 경우에는 「의료급여법 시행규칙」 제3조의 의료급여절차에 따라 진료를 받으셔야 하며, 선택의료급여기관 적용 대상자는 본인이 선택한 의료급여기관에서 먼저 진료를 받으셔야 합니다.

※ 위암은 우리나라 암 발생률 1위로 정기검진을 통해 조기 발견이 가능하며, 조기 발견된 경우 내시경적 치료 또는 수술적 치료로 완치 가능한 암입니다.

※ 위암은 40세이상에서 급격하게 증가하므로 특별한 증상이 없더라도 40세이상 남녀 모두 2년 마다 위조영술 또는 위내시경을 받을 것을 권고하고 있습니다. 위장조영검사 결과 판정소견이 위암의심, 조기위암, 진행위암인 경우에는 다음연도 1월말까지 위내시경검사를 받을 수 있습니다.

※ 위암검진 결과가 이상소견이 없더라도 복통, 속쓰림 등의 증상이 있을 경우 의사와 상담이 필요하고, 검사결과 이상소견 없음 이외의 판정을 받은 경우 권고사항에 따라 조치를 취하시기 바랍니다.

※ 위암 선정특례자로 등록된 수검자는 선정특례 종료일까지 위암검진을 유예할 수 있습니다.

※ 위암으로 진단받은 사람 중 관련 요건(소득·재산 또는 건강보험료 납부액, 국가 암검진 수검 여부 등)을 갖 춘 사람은 암환자 의료비 지원사업의 대상이 될 수 있습니다.(상세 내용은 관할 보건소 문의)

귀하의 위암 검진 결과를 위와 같이 통보합니다.

2025년 10월 30일

요양기관기호

11366338

검진기관명

재단법인한국의학연구소강남의원

유방암 검진 결과통보서

성명	윤정혜	주민등록번호	691023-2*****		
구분	검사항목	결과	판정		
유방암	유방촬영(양측) 2025/10/17	-이상소견없음	이상소견없음	유방 X-선 검사상 치밀유선조직 소견입니다. 유방조직이 치밀한 상태로 실제 병소가 가려질 수 있습니다. 유방속의 숨어있는 보이지 않는 병변발견을 위해서는 초음파 검사를 하시기 바랍니다.	
				권고사항	
				판정일	판정의사
	2025년 10월 17일			21742	유희선

유방암 검진 결과통보서

- ※ (건강보험가입자) 건강검진 결과통보서상 상급종합병원에서의 요양급여가 필요하다는 의사 소견이 기재된 경우, 요양급여의뢰서(진료의뢰서)로 갈음되며 본 통보서를 활용하여 상급종합병원에서 진료를 받으실 수 있습니다.
- ※ 의료급여수급권자) 건강검진 결과 이상소견이 발견되어 진료담당의사가 검진결과서에 추가 진료가 필요하다는 의사소견을 기재한 경우 등 검진결과서를 의료급여의뢰서로 갈음하여 검진을 실시한 의료급여기관에서 진료를 받으실 수 있습니다. 그 이외의 의료급여가 필요한 경우에는 「의료급여법 시행규칙」 제3조의 의료급여절차에 따라 진료를 받으셔야 하며, 선택의료급여기관 적용 대상자는 본인이 선택한 의료급여기관에서 먼저 진료를 받으셔야 합니다.
- ※ 최근 빠르게 증가하고 있는 유방암은 정기검진을 통해 조기 발견과 치료가 가능합니다.
- ※ 유방암 조기검진을 위해서 40세 이상의 여성은 2년에 한 번씩 유방촬영검사를 받을 것을 권고하고 있습니다.
- ※ 유방암검진 결과 이상소견이 없더라도 유방 수술을 받은 적이 있는 분과 유두 출혈이 있거나 유방에 몽우리가 만져지는 분은 반드시 의사와 상담이 필요하고, 검사결과 이상소견 없음 이외의 판정을 받은 경우 권고사항에 따라 조치를 취하시기 바랍니다.
- ※ 유방암 산정특례자로 등록된 수검자는 산정특례 종로일까지 유방암검진을 유예할 수 있습니다.
- ※ 유방암으로 진단받은 사람 중 관련 요건(소득·재산 또는 건강보험료 납부액, 국가암검진 수검 여부 등)을 갖춘 사람은 암환자 의료비 지원사업의 대상이 될 수 있습니다.(상세 내용은 관할 보건소 문의)

귀하의 유방암 검진 결과를 위와 같이 통보합니다.

2025년 10월 30일

요양기관기호

11366338

검진기관명

재단법인한국화학연구소강남의원



건강한 뇌 만들기, 작은 것부터 시작하세요!

CogMate™

결과리포트

실시일 2025년 10월 17일

ID	성명	연령	성별
2506902879	윤정혜	55 (세)	여성

이 결과리포트는 브레인퍼포먼스(뇌 건강도) 저하 가능성을 판별하는 것입니다.

[CogMate]는 브레인퍼포먼스 저하 가능성에 관련한 집중력 점수와 기억력 점수를 나타냅니다.

개인의 브레인퍼포먼스를 나타내는 지표는 0~50의 수치로 표시됩니다.

*반드시 읽어주세요(필독)

이 결과리포트로 제공되는 정보는 질병의 예방이나 조기 발견에 대한 관심을 위한 것으로, 의사의 조언이나 현재 받고있는 치료를 대신할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 이 리포트로 제공되는 정보나 결과는 질병의 예방이나 진단을 위한 것이 아닌 점 양해 바랍니다.

브레인퍼포먼스인덱스 (BPI: Brain Performance Index)

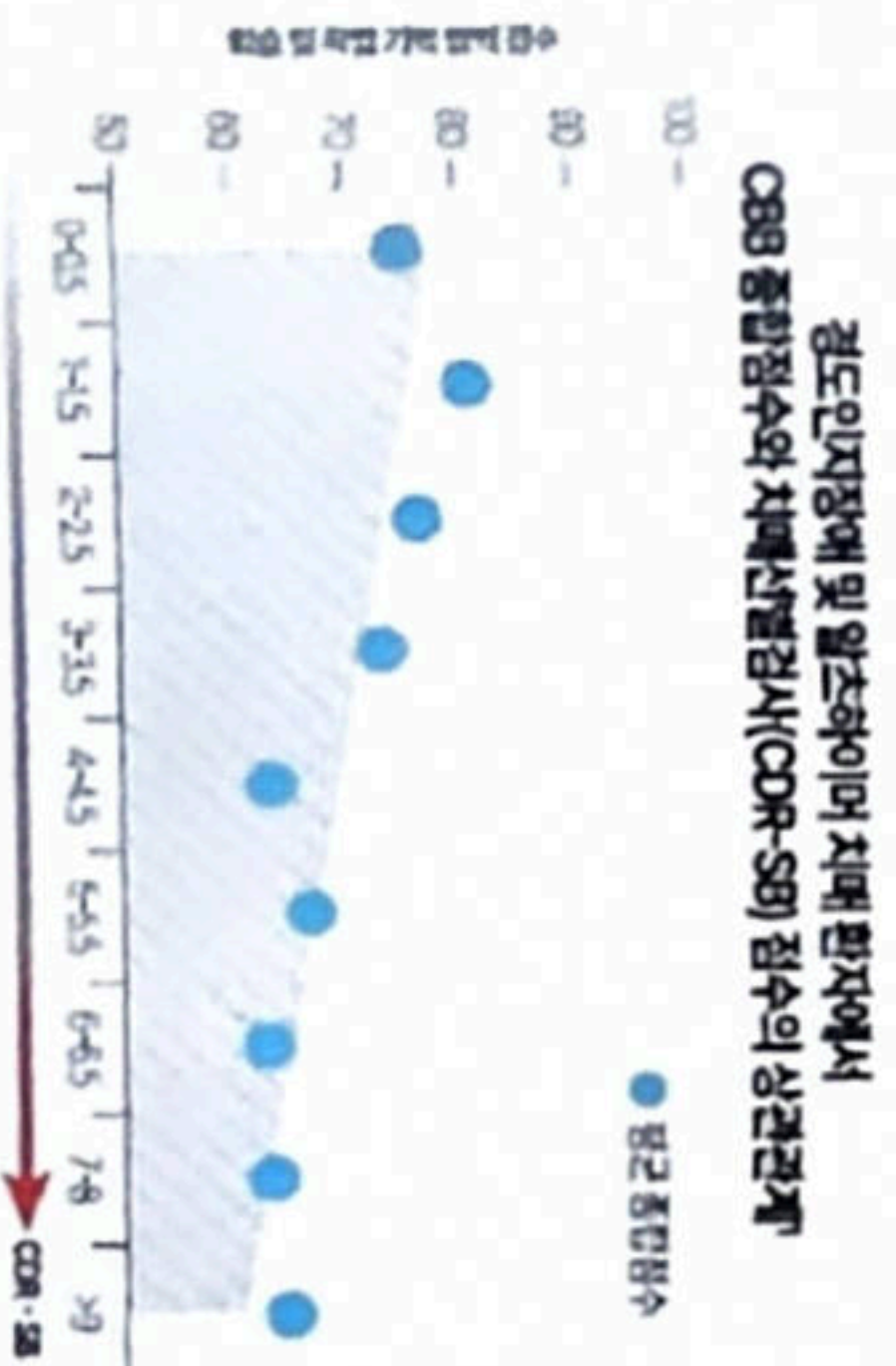
BPI는 집중력, 기억력, 시각학습, 주의력, 반응 속도를 종합 평가하는 '뇌 건강 지수'입니다.

A : 정상입니다.	B : 경계선입니다.	C : 유지 및 증진 활동 필요
20.0 ~ 50.0	15.0 ~ 19.9	0.0 ~ 14.9

집중력 점수	19 (점) [B]	집중력 점수인 브레인퍼포먼스 관련 반응 속도나 주의력을 종합적으로 평가한 점수입니다.
기억력 점수	30.5 (점) [A]	기억력 점수인 브레인퍼포먼스 관련 시각 학습이나 기억력을 종합적으로 평가한 점수입니다.
나이	50 (세)	*CogMate의 테스트 결과는 검사자의 나이를 기반으로 합니다. 해당 결과는 건강의 지표로 유용하게 사용될 수 있습니다.

CBB 종합점수는 경도인지장애 및 치매 진단 검사와 유의미한 관계를 나타냅니다.

CBB 종합점수는 치매선별검사(CDR-SB) 점수와 통계적으로 유의한 상관관계가 있음이 관찰되었습니다!



한국에이지주식회사

전화: 02-3451-5550(1번)

브레인퍼포먼스 유지 및 향상방법

생활습관 개선

규칙적인 운동

뇌의 활성화를 위해 주 2회 30분 이상의 유산소 운동을 추천합니다.

건강한 식습관

아채, 과일, 생선 섭취 부족은 인지기능 저하의 위험을 초래합니다. 균형잡힌 식사를 추천합니다.

금연

흡연자는 비흡연자에 비해 1.5~2배 정도 인지기능 저하의 위험이 높습니다. 금연을 추천합니다.

과음저제

과도한 음주는 인지기능 저하에도 영향을 줄 수 있습니다. 과음은 피하세요.

체중 관리

비만은 인지기능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 식단과 운동으로 체중을 조절해주세요.

혈압 관리

중년 고혈압은 인지기능 저하의 원인입니다. 예방을 위해서는 염분 섭취를 줄여주세요.

혈당 관리

혈당 관리가 되지 않으면 인지기능이 저하됩니다. 공복 시 혈당 100mg/dl 이상이면 당뇨병 발생의 위험이 2배 이상 높아집니다.

콜레스테롤 관리

콜레스테롤의 증가는 인지기능 저하의 원인이 됩니다. 식이섬유가 많은 식품을 섭취하세요.

마음 건강

우울증은 인지기능을 2배 이상 저하시킵니다. 질 높은 수면을 유지해주세요.

청력 유지

청력 기능이 떨어지면 인지기능이 저하될 위험이 있습니다. 대화를 들려주세요.

지적 활동

생각하고, 기억하고, 판단하는 등 일상 생활의 적극적인 지적 활동을 통해 인지기능 저하를 예방할 수 있습니다. 인지기능 저하 예방에 도움이 됩니다.

사회 활동

외로움은 인지기능을 저하시킬 수 있습니다. 적극적인 사회 활동을 통해 인지기능을 활성화해주세요.

그 외

심신관리

자세한 사항은 홈페이지를 참고해주세요.
 *치매질환진료가이드라인 2017, 치매질환진료가이드라인 작성위원회, p131

- 정기적인 검사를 추천합니다.
 정기적으로 검사를 실시하여 검사자의 브레인퍼포먼스 추이를 확인할 수 있습니다. 이전과 비교 시 브레인퍼포먼스 저하의 가능성이 있다고 판정되신 분은 3개월 내에 재검사를 추천드립니다.
- 여러가지 원인이 있습니다.
 브레인 퍼포먼스 저하의 원인은 수많은 이유가 있습니다. 브레인퍼포먼스의 저하를 불러오는 위험한 요인: 스트레스, 불안감, 주의결함장애, 우울증, 갑상선 질환이나 당뇨병 등의 성인병, 음주나 화학 조미료 의존, 비타민 B12 부족, 뇌혈관 질환, 의약품, 두부외상 등.

이 결과리포트로 제공되는 정보는 질병의 예방이나 조기 발견에 대한 관심을 위한 것으로, 의사의 조언이나 현재 받고 있는 치료를 대신 할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 이 리포트로 제공되는 정보나 결과는 질병의 예방이나 진단을 위한 것이 아닌 점 양해 바랍니다.

한국의학연구소 건강검진 결과



건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 윤정혜

나이 | 55세

성별 | 여성

종합 평가

윤정혜 님의 점수: 67 점

보통

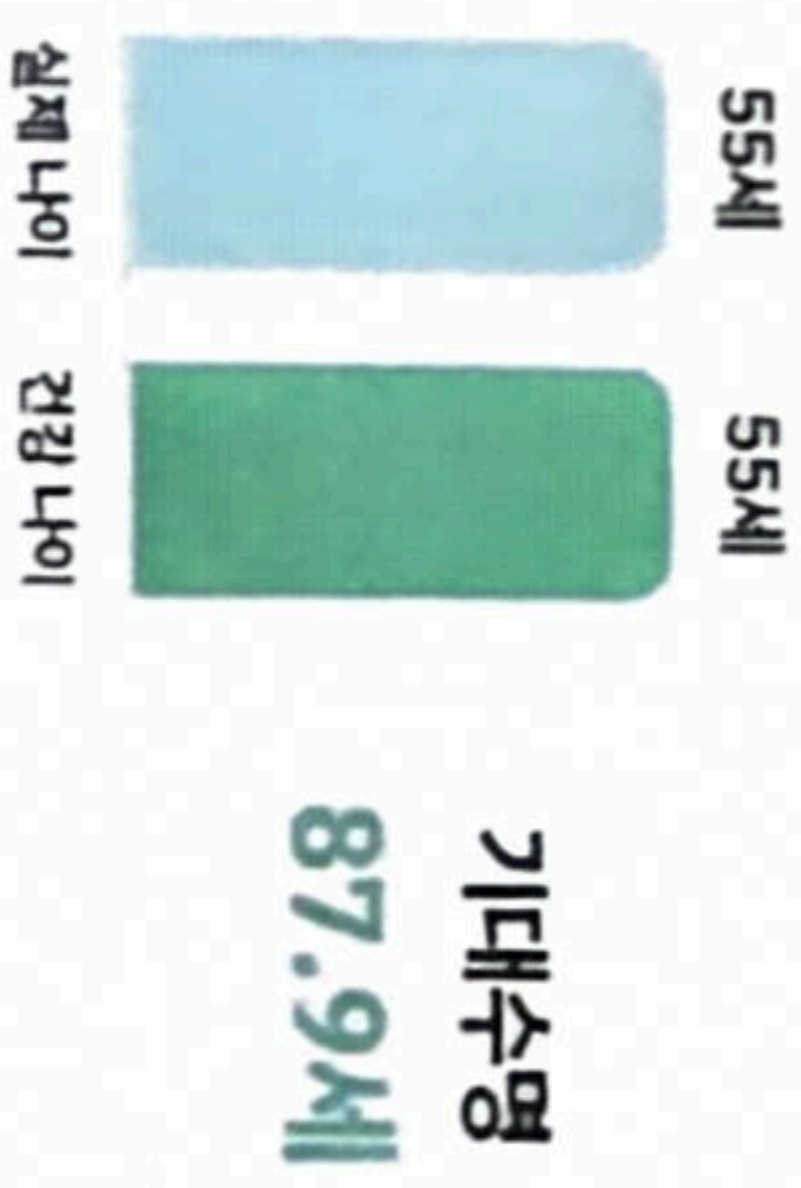


통일 연령대 평균 점수 78점

대한민국 성인 여성 100명 중 73등

통일 연령대(55~59세 여성) 100명 중 70등

건강 나이



기대수명

87.9세

윤정혜 님의 종합 건강 성적은 **보통**입니다. 통일 연령대 대비 낮은 점수를 가지고 계시네요.

종합 평가 및 건강 나이는 검진 결과, 생활습관(흡연, 음주, 신체활동), 그리고 기저 질환 여부를 종합하여 산출됩니다. 각 등급은 건강 점수와 통일 연령대비 상대적인 건강 수준을 함께 고려하여 분류됩니다.

이번 건강검진 결과를 고려했을 때, 윤정혜 님의 건강 나이는 55세로, 실제 나이와 동일하고, 기대 수명은 87.9세입니다.

※ 55세 대한민국 여성의 평균 기대 수명은 87.9세입니다.

신체건강과 생활습관 성적

신체건강 성적은 신체건강 성적은 검진 결과로 계산됩니다.

항목	심장	체장	신장	간	혈관	폐	비만
등급	보통	미흡	우수	우수	우수	-	보통
점수	51점	45점	74점	67점	72점	-점	59점
등수 (통일 연령대 기(준))	48/100	82/100	27/100	39/100	26/100	-/100	24/100

생활습관 성적 생활습관 성적은 설문 응답 내용으로 계산됩니다.

기저 질환 설문 응답 내용으로 표기됩니다. ● 해당 ● 미해당

항목	흡연	음주	신체활동	고혈압	이상지질혈증	당뇨	심혈관질환
등급	최우수	최우수	보통	고혈압	이상지질혈증	당뇨	심혈관질환
점수	100점	100점	55점	고혈압	이상지질혈증	당뇨	심혈관질환
등수 (통일 연령대 기(준))	1/100	1/100	9/100	뇌혈관질환	간경화	치매	암질환

건강성적표 어떻게 해석할까요?

해석 방법 확인과 추가 문의는 좌측의 QR 코드를 스캔해 주세요.

위 서비스는 한국인을 대상으로 비교한 결과를 보여주고 있습니다.



한국의학연구소 건강검진 결과



건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 윤정혜

나이 | 55세

성별 | 여성

신체건강 성적 세부 항목

신체건강 성적 산출에 활용되는 세부 검진 결과를 확인할 수 있습니다. 검진 결과가 정상범위 내에 있는지, 동일 연령대 대비 건강 수준이 어떠한지 비교해 보세요. 이 결과는 참고용이며, 질병 진단이나 개별 수치의 의미는 전문의 상담을 권장합니다.

동일 연령대 대비 00(검사결과 - 동일 연령대 평균) □ 위함범위 ■ 정상범위 ▼ 현재 나의 위치 ▲ 동일 연령대 평균

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
신장	51점	보통
수축기 혈압	116 (#4)	▲
이완기 혈압	67 (#9)	▼
최고-최저 혈압	49 (#5)	▼

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
총콜레스테롤	194 (#10)	▲
LDL	102 (#22)	▼
HDL	58 (#3)	▼
*HDL/LDL ratio	0.57 (#0.1)	▲

Barter P. et al., N Engl J Med (2007)

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
신장	74점	우수
크레아티닌	0.68 (0)	▼
BUN	13 (#2)	▼
요단백	음성 (0)	▼
사구체 여과율 (GFR)	98 (#5)	▼

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
폐	미시행	
FVC(%)	- (-)	▲
FVC(L)	-	
FEV1(%)	- (-)	▲
FEV1(L)	-	
FEV1/FVC	- (-)	▲

여성 평균 수치는 3.0L 입니다.

* 해당 수치의 기, 연할, 계층을 고려하여 %값이 산출됩니다*

여성 평균 수치는 2.4L 입니다.

* 해당 수치의 기, 연할, 계층을 고려하여 %값이 산출됩니다*

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
간	67점	우수
AST	28 (#5)	▼
ALT	13 (#8)	▼
GTP	12 (#14)	▼

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
비만	59점	보통
BMI	18.6 (#5.3)	▼
허리둘레	69 (#12)	▼
중성지방	169 (#44)	▼

한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI) 검사일시 | 2025.10.17
성명 | 윤정혜 나이 | 55세 성별 | 여성

만성질환 10년 내 발병 확률

연령, 성별, 기저질환, 복용 약물, 검진 자료, 생활습관을 종합적으로 고려하여 예측한 10년 내 만성질환 발병 확률을 확인할 수 있습니다. 동수는 동일 연령대 100명을 기준으로 표기되며, 위험 요인은 연령, 성별을 제외한 주요 요인으로 표기됩니다. 동일 연령대 평균과 나의 확률을 비교하고, 질환 발병 확률을 높이는 요인을 확인해보세요. 단, 해당 수치는 통계적 예측값으로 진단이나 치료 목적으로는 사용할 수 없습니다.

▼ 나의 확률 ■ 동일 연령대 확률 범위 : 동일 연령대 평균 확률 ■ 정상 범위 초과 ■ 동일 연령대 대비 관리 필요 ■ 해당 없음
*기타는 확률 산출에 활용된 주요 4개 요인 외 모든 요인을 포함하며, 하나라도 해당하면 해당 요인이 하단에 표기됩니다.
*질환명(속정 지표/약)은 이번 검진에서 측정 지표값이 해당 질환 의심 범위에 해당하거나, 해당 질환 치료를 위해 약물 복용 중이라고 응답한 경우 표기됩니다.

대사성 질환



위험 요인

고혈압 가족력	높은 수축기 혈압
높은 이완기 혈압	높은 BMI
*당뇨(속정 지표/약), 신체활동 부족	

위험 요인

고혈압(속정 지표/약)	당뇨(속정 지표/약)
높은 LDL/HDL 비율	*기타

주요 질환



위험 요인

당뇨(속정 지표/약)	심혈관질환 가족력
고혈압(약)	*기타
*신체활동 부족	

위험 요인

당뇨(속정 지표/약)	신장기능저하(CFR<60)
현재 흡연	높은 혈압
*신체활동 부족	

위험 요인

높은 AST	고위험 음주
바이러스성 간염	현재 흡연
*당뇨(약)	

위험 요인

당뇨(속정 지표/약)	현재 흡연
심혈관 질환	*기타
*신체활동 부족	

한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI) 검사일시 | 2025.10.17

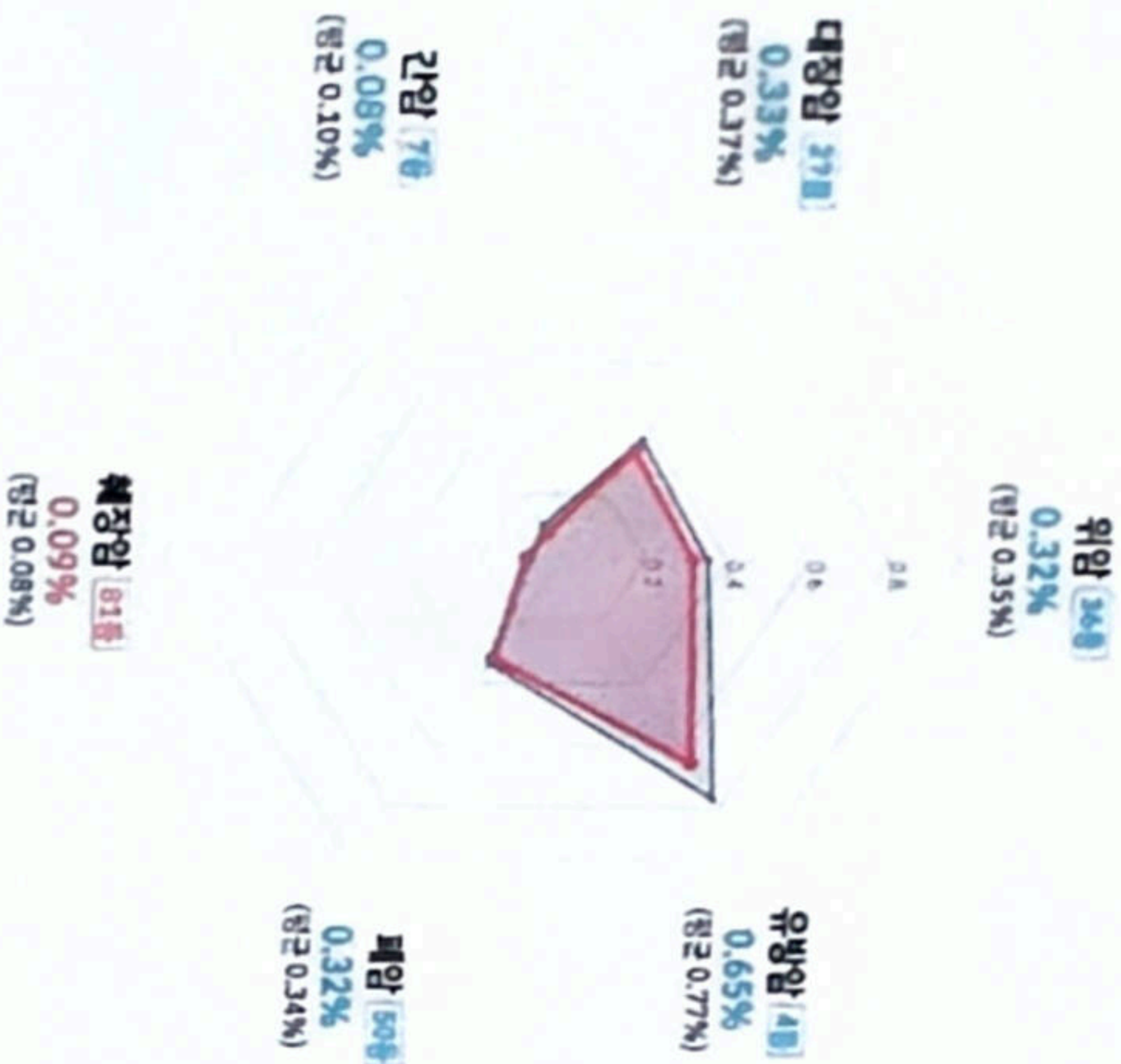
성명 | 윤정혜 나이 | 55세 성별 | 여성

! 주요 암 6종 10년 내 발병 확률

만성질환 발병 확률과 동일인 방법으로, 주요 암 6종의 10년 내 발병 확률을 확인할 수 있습니다. 차트를 통해, 발병 확률이 높은 암종과 위험요인을 확인해 보세요. 단, 발병 확률은 통계적 예측값으로 진단이나 치료 목적으로는 사용할 수 없습니다.

암질환

— 나의 확률 — 동일 연령대 평균 확률
동일 연령대 평균 대비 ● 높음 ● 낮음 × 유질환자는 확률 및 동수가 표기되지 않습니다.



※ 암 가족력은 전세 암 종류 중 하나라도 가족력이 있다고 응답하신 경우 표시됩니다.

🔴 동일 연령대 대비 동수가 가장 안 좋은 암은 췌장암입니다.

윤정혜님의 동일 연령대 대비 동수가 가장 안 좋은 암은 **췌장암(81등)** 입니다. **당뇨(축정 혈당/약)** 요인이 해당 질환의 발병 확률을 높이고 있어 이에 대한 적극적인 관리가 필요합니다.

위험요인

1 위암

만성 위축성 위염/위궤양 저체중
누적 흡연량 낮은 혈색소 *기타

* 당뇨(축정 혈당/약)

2 대장암

고혈압(축정 혈압/약) 만성 염증성 대장질환
당뇨(축정 혈당/약) 저체중 *기타

* 신체활동 부족

3 간암

간경화 바이러스성 간염
높은 ALT 높은 AST *기타

* 당뇨(약)

4 췌장암

당뇨(축정 혈당/약) 암 가족력
저체중 높은 GTP *기타

5 폐암

만성 폐색성 폐질환 당뇨(축정 혈당/약)
누적 흡연량 저체중 *기타

* 높은 AST/ALT 비율, 신체활동 부족

6 유방암

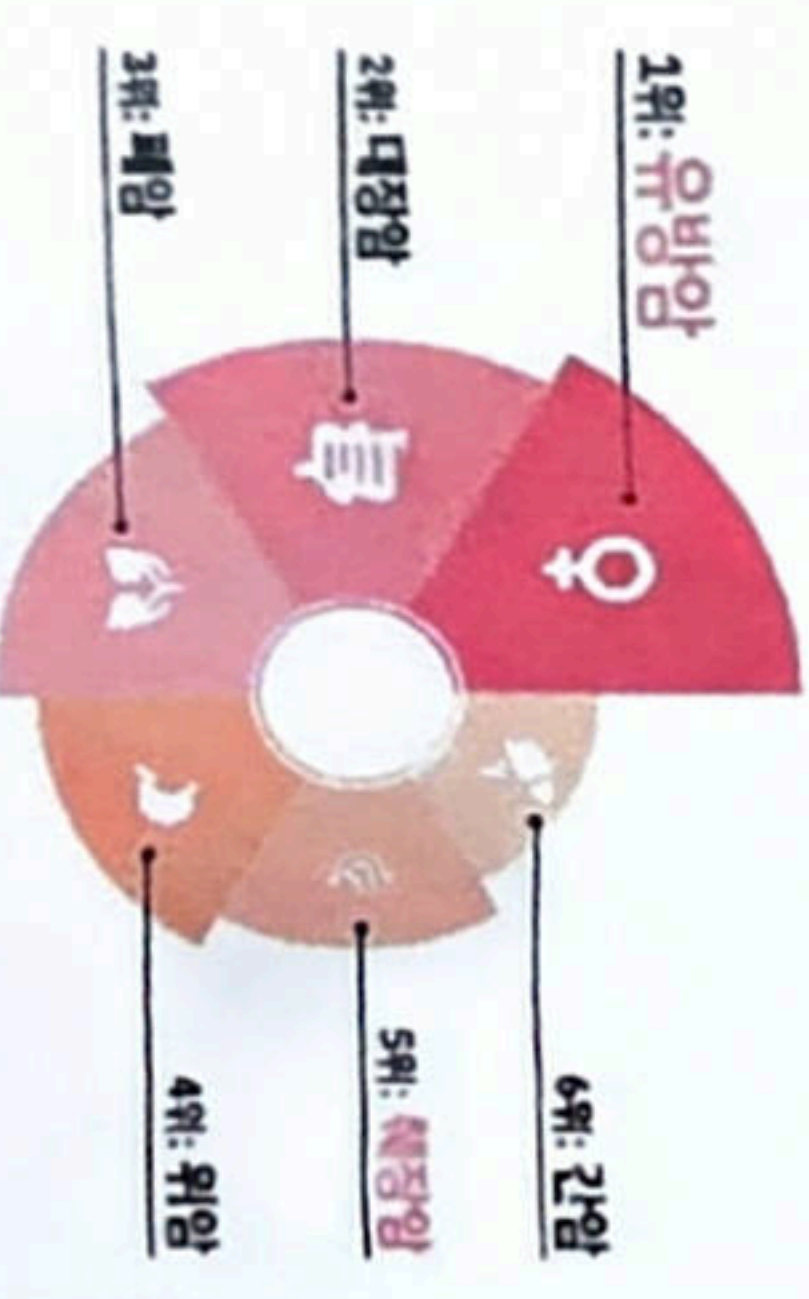
호르몬 치료 여부(2년 이상) 암 가족력
이른 초경 늦은 폐경 *기타

♀ 동일 연령대에서 가장 많이 발생하는 암은 유방암입니다.

위에서는 위험요인을 고려한 발병 확률(통계적 예측값)을 알아봤다면, 우측 그래프를 통해 실제로 동일 연령대에서 많이 발생하는 암종 순서를 확인할 수 있습니다.

윤정혜님의 경우, 유방암에 대한 발병 확률이 동일 연령대 평균보다는 낮지만 동일 연령대에서 발병 빈도가 높은 암이므로 특히 더 관심을 갖고 관리해주세요.

※ 55-59세 여성에게 많이 발생하는 암은?



한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 윤정혜

나이 | 55세

성별 | 여성

! 위험 요인 잡고 건강 지키기

아래 버블들은 건강에 영향을 미치는 위험 요인을 나타냅니다. 크기는 해당 요인의 영향력을, 색상은 관리 필요도를 의미합니다. 위험도가 큰 요인을 관리하여 건강 성적을 향상시킬 수 있는 방안을 함께 알려드립니다. 위험 요인 관리를 실천하고, 정기적인 검진을 통해 위험 요인이 개선되는지 확인해 보세요.



운동해님에게 우선순위가 높은 주요 위험 요인은 **당뇨, 혈당이상, 지질수치이상**입니다. 해당 요인들을 관리할 수 있는 맞춤 건강관리 팁을 확인해보세요.

건강한 변화를 위한
건강관리의 첫걸음!

건강관리의 완성!
조금만 더 힘내요!

STEP 3 좋은 식습관으로 건강 완성하기

❌ 피해야 할 식사
단순당(설탕, 꿀) 섭취, 정제곡물, 포화지방
및 트랜스 지방이 많은 식품

✔ 도움이 되는 식사
식이섬유가 풍부한 식품, 불포화지방산이
풍부한 식품

이렇게 드시면 좋아요:
적정량의 균형 잡힌 식사, 규칙적으로 하기
식사 순서 바꾸기
• 채소나 단백질을 먼저 섭취하면 열량
제한과 혈당 조절에 도움이 돼요
당지수 낮은 식품 선택하기
• 잡곡밥, 통밀빵, 콩류, 채소, 해조류(미역,
다시마 등)

STEP 2 운동으로 위험요인 개선하기

★ 유산소 운동
중강도 기준*주당 150분 이상 시행
(150분을 최소 5일 이상 나누어 진행)

🏊 근력 운동
주당 2일 이상 시행
(모든 부위 포함, 휴식일을 두고 시행)

내 건강에는 이런 효과가 좋아요:
지질 수치, 혈당, 비만도 개선

운동시 이런 점은 주의가 필요해요:
저혈당 위험 피하기
※ 운동 전/후 혈당 확인하기
※ 혈당 변동이 크다면 의사 상의 필요

STEP 1 건강에 해로운 습관 하지 않기

🚭 흡연
금연유지, 간접 흡연 조심하기

🍷 음주
금주 습관 유지하기

내 건강에는 이런 이유로 더 위험해요:

- ❌ 혈당 상승, 심뇌혈관 위험 증가
- ❌ 저혈당 발생 위험, 증상지방 증가

*중강도 운동: 약간 숨이 차지만, 대화 가능한 정도